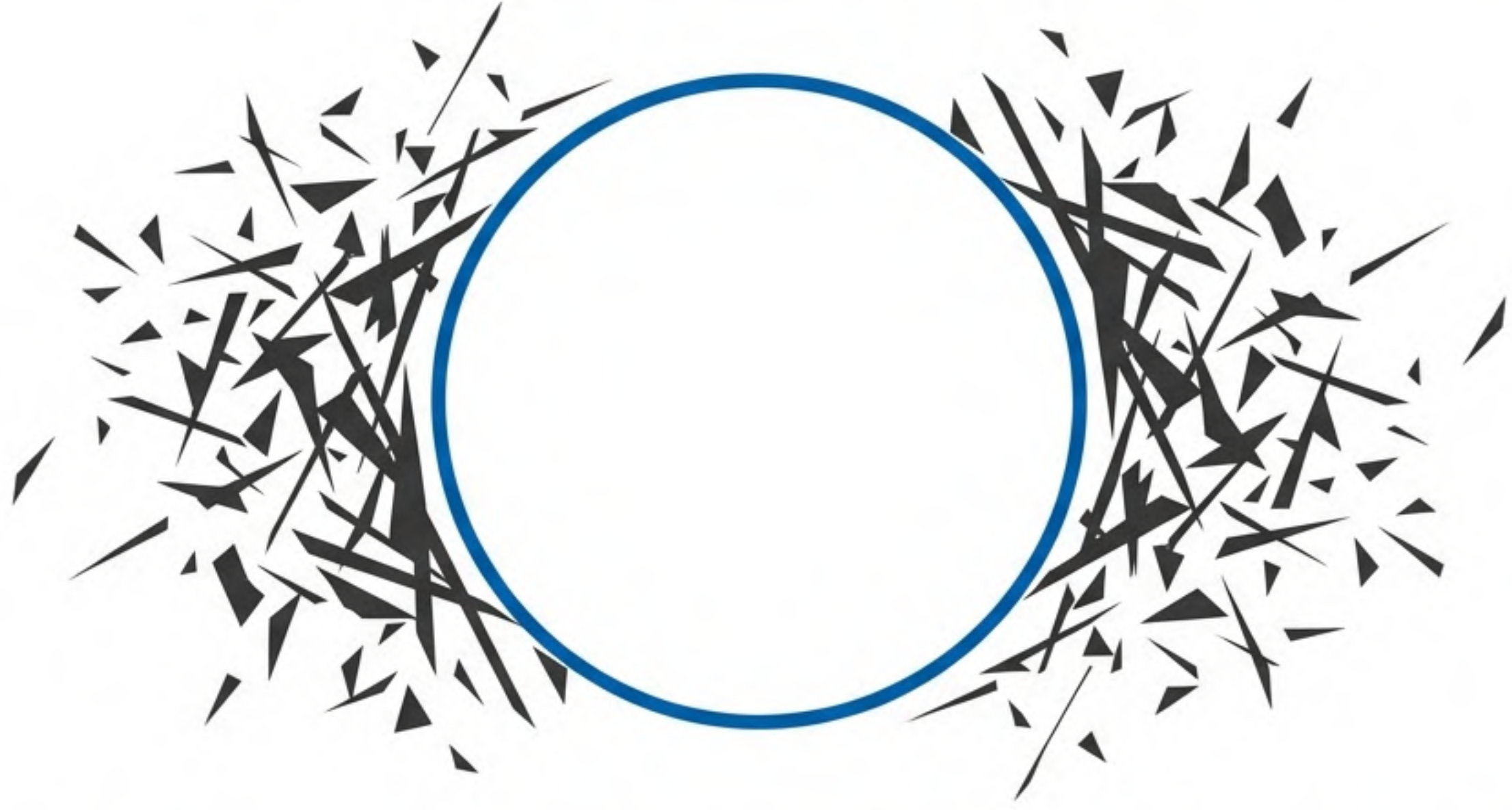




Hasta, Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirmesi

İlk Yardımcının Yol Haritası: Güvenlik, Tanı ve Müdahale

Olay Yeri Güvenliđi: Önce Can Güvenliđi



Trafik Kontrolü

Aracı güvenli alana çek, kontađı kapat, el frenini çek.



Görünürlük

Üçgen reflektörler ile işaretle (ön ve arka).



Patlama Riski

Gaz vanalarını kapat (LPG), sigara içilmesine izin verme.



Kalabalık Yönetimi

Meraklı kişileri uzaklaştır.



Ortam

Gaz varsa havalandır, kıvılcım çıkaracak cihaz kullanma.

Yaralının Korunması ve 112



Inter Tight Hareket Ettirme

Tehlike yoksa yaralı yerinden oynatılmamalıdır.



Inter Tight Beslenme

Bilinç kapalıysa ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.



Inter Tight Isı Kontrolü

Hasta/yaralı sıcak tutulmalıdır.



Inter Tight Psikolojik Destek

Endişeler giderilmeli, yarasını görmesine izin verilmemelidir.



Inter Tight İletişim

Tıbbi yardım istenmelidir (112).

Yaşam Bulguları: Vücudun Sinyalleri



Bilinç

Beyin fonksiyonlarının durumu.



Solunum

Akciğerlerin oksijen alımı.



Dolaşım

Kalp ve damar sistemi aktivitesi.



Vücut Isısı

Metabolizma dengesi.



Kan Basıncı

(Not: İlk yardımda ölçülmez, ancak anlamı bilinmelidir).

Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi



Action: Hasta omzuna hafifçe dokunularak “İyi misiniz?” diye sorulur.

Solunum Deęerlendirilmesi



Yetiřkin



Çocuk

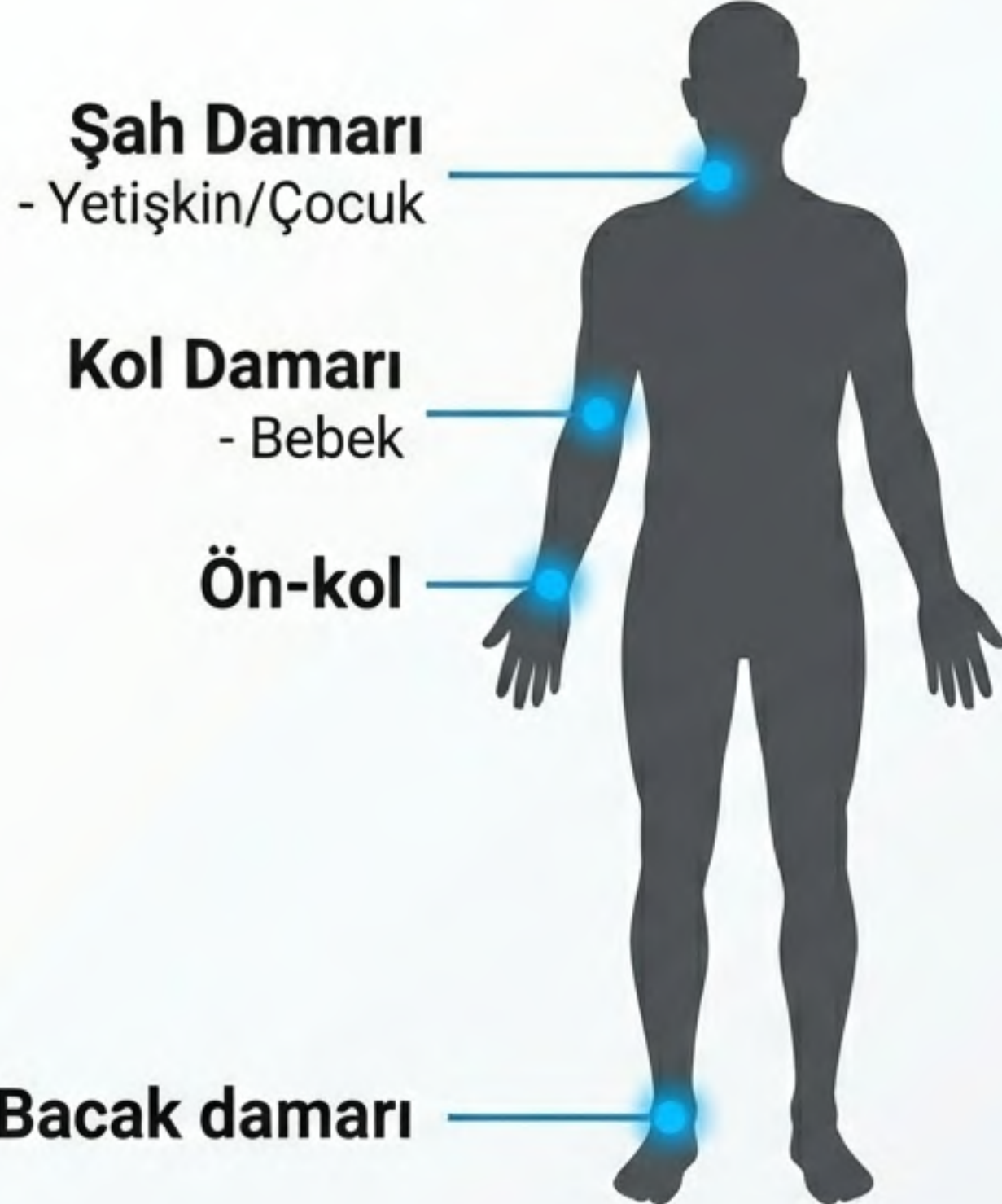


Bebek



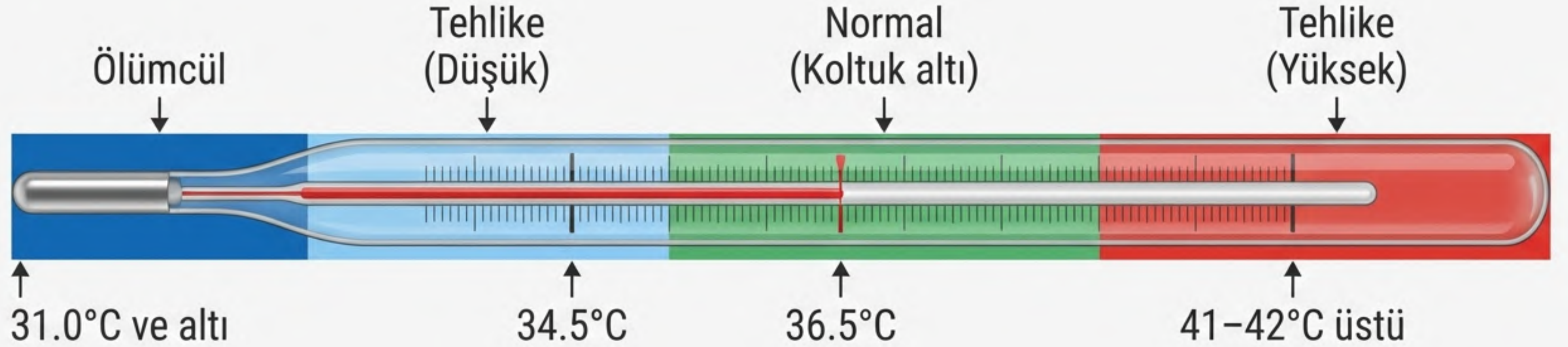
Deęerlendirme Kriterleri: Solunum sıklığı • Solunum aralıklarının eřitlięi • Solunum derinlięi

Dolařım ve Nabız



Grup	Kalp Hızı (dakika)
Yetiřkin	60–100
Çocuk	100–120
Bebek	100–140

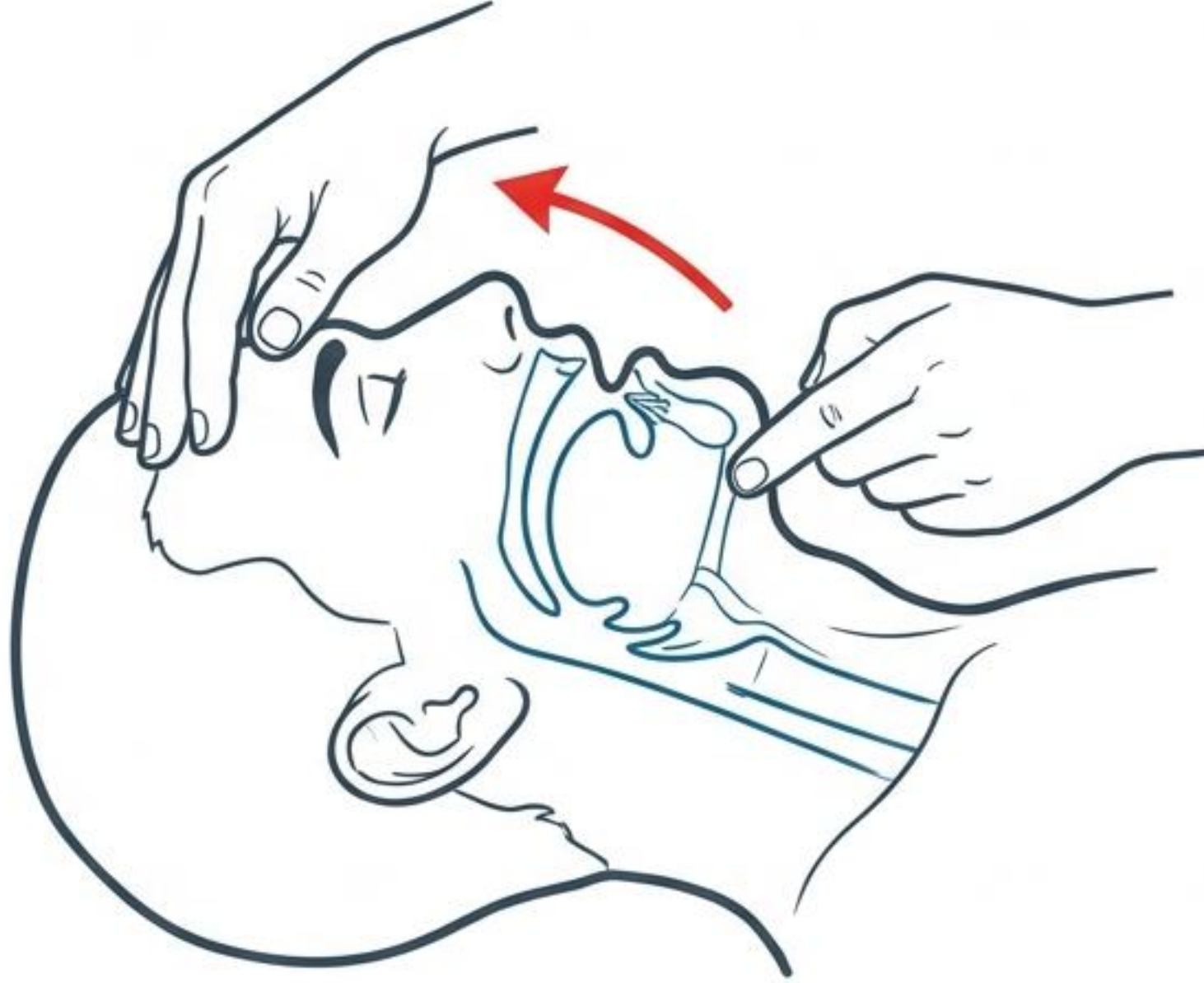
Vücut Isısı Değerlendirilmesi



İlk Değerlendirme: Hayat Kurtarma Protokolü



A: Havayolu Açıklığının Sağlanması



Baş Geri - Çene Yukarı Pozisyonu

1. Temizlik: Ağız içi gözle kontrol edilir, yabancı cisim varsa işaret parmağı ile çıkarılır.

2. Pozisyon: Bir el alna, diğer elin 2 parmağı çene kemiğine konur.

3. Hareket: Baş geriye itilir, çene yukarı kaldırılır.

Not: Sert hareketlerden kaçınılmalıdır.

B: Solunumun Değerlendirilmesi

BAK: Göğüs kafesi hareketlerine bakılır.



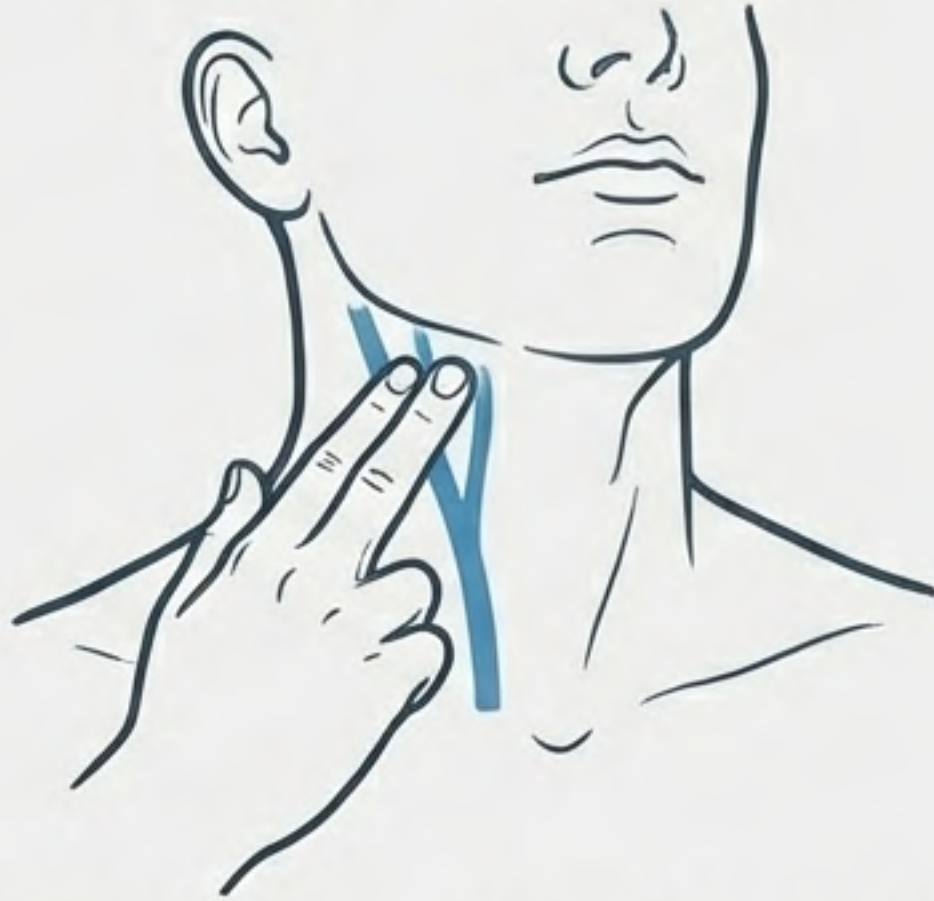
DİNLE: Solunum sesi dinlenir.

HİSSET: Soluk yanağında hissedilmeye çalışılır.

KRİTİK SÜRE: 10 Saniye. Solunum yoksa derhal yapay solunuma başlanır.

C: Dolaşımın Değerlendirilmesi

Yetişkin ve Çocuk



Şah damarından (boyun)
3 parmakla.

Bebek



Kol atardamarından
(dirsek üstü iç yüz).

Süre: 5 saniye. **Karar:** Solunum ve nabız varsa -> Koma Pozisyonu.

i: İkinci Değerlendirme: Görüşerek Bilgi Edinme



- **İletişim:**
Kendini tanı, isim öğren, hoşgörülü ol.
- **Sorgulama:**
 - Olayın mahiyeti nedir?
 - Özgeçmiş (Hastalıklar)?
 - Son ne yediler?
 - Kullanılan ilaçlar?
 - Alerji var mı?

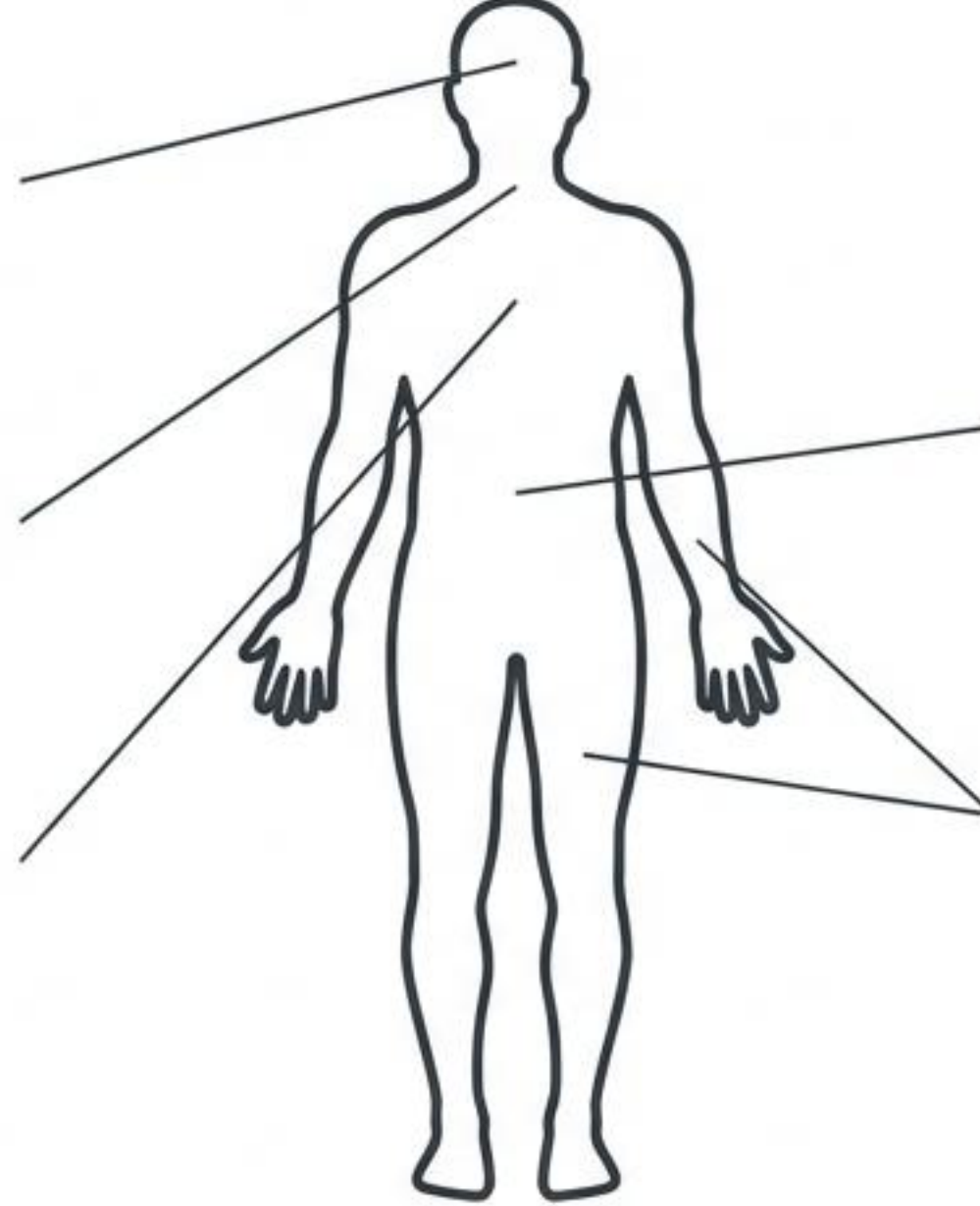
Görüşerek bilgi edinme süreci, hasta stabilizasyonu için kritiktir.

Baştan Aşağı Kontrol

Baş: Saçlı deri, kulak/burun akıntısı, ağız içi.

Boyun: Ağrı, hassasiyet, şişlik (Boyun zedelenmesi ihtimali!).

Göğüs: Saplanmış cisim, hareketlerde simetri, kanama.



Karın: Sertlik, duyarlılık, morarma.

Kol/Bacak: Kuvvet, his kaybı, kırık, nabız.

Tüm vücudu sistematik olarak kontrol edin, yaralanmaları belirleyin.

Özet: Müdahale Akışı



Yardım ekibi gelene kadar olay yerinden ayrılmayın.